

GUÍA ENTRENATZAILE

Correr no te destroza las rodillas

Lo que de verdad lesiona tu rodilla no es correr —y tiene solución.
Una guía honesta sobre el dolor de rodilla en personas activas.

ENTRENATZAILE · ALAIN ZULAIKA

"Como sigas corriendo te vas a cargar las rodillas." Lo habrás oído mil veces. Puede que hasta lo hayas pensado tú, la última vez que la rodilla te dio guerra tras una salida al monte.

Es uno de los mitos más extendidos y más falsos que existen sobre el cuerpo. Y creértelo tiene un coste: te frena, te asusta y te empuja al sofá, que es justo lo peor que puedes hacer. Vamos a desmontarlo con datos.

El mito, contra los números

Cuando comparas a corredores con no corredores —y se ha hecho, con más de 14.000 personas— el resultado sorprende a casi todo el mundo:

Los que NO corren tienen MÁS dolor de rodilla

y casi el doble de riesgo de acabar
necesitando una prótesis de rodilla

No hay diferencias en el desgaste del cartílago entre quien corre y quien no. Hay **menos** dolor de rodilla entre los que corren. Y el riesgo de acabar en el quirófano por artrosis es mayor en los sedentarios (4,6%) que en los corredores (2,6%).

Correr, de hecho, parece **proteger** la rodilla: la carga hace que la articulación se adapte y se fortalezca, igual que un músculo. La rodilla no es un neumático que se gasta con los kilómetros. Es tejido vivo que responde al uso.

Entonces, ¿por qué me duele?

Que correr no destroce la rodilla no significa que el dolor no sea real. Lo es. Pero la causa no es "correr". Es **correr más de lo que tu rodilla tolera en ese momento**.

Piénsalo como una cuenta bancaria de carga. Tu rodilla tiene un saldo de tolerancia. Si le pides más de lo que tiene —un volumen que sube de golpe, muchas bajadas de monte seguidas, poca fuerza de base— te quedas en números rojos, y ahí aparece el dolor.

La buena noticia: ese saldo **se puede aumentar**. Una rodilla más fuerte y mejor preparada tolera más carga sin protestar. El problema no es el kilometraje; es la diferencia entre lo que pides y lo que tu rodilla está preparada para dar.

Lo peor que puedes hacer: parar del todo

El instinto, cuando duele, es dejar de moverse y "descansar hasta que se pase". Es justo el error.

El reposo completo desacondiciona: pierdes fuerza, la rodilla se vuelve aún menos capaz, y cuando vuelves, recaes. Además alimenta el miedo —empiezas a moverte con cuidado, a evitar, a protegerte— y ese miedo, está demostrado, alarga el problema.

Lo que funciona no es descargar, es **cargar bien**: ajustar la actividad sin eliminarla, y construir la fuerza que aumenta tu tolerancia.

Tres claves que la ciencia respalda

- **La fuerza es el tratamiento, no el reposo.** Fortalecer la rodilla y la cadera es la intervención con más respaldo para el dolor de rodilla por actividad. Y hazlo *de verdad*: los ejercicios blandos rinden mucho menos que cargar con intención.
- **Guíate por el dolor, con criterio.** Una molestia leve que baja rápido no es alarma. Un dolor que sube, que no se va en un rato, o que sigue al día siguiente, sí dice "modifica". No es "aguanta como sea" ni "para del todo": es escuchar la señal.
- **Las bajadas de monte cargan mucho.** Si tu dolor aparece tras el monte, los descensos son probablemente el mayor culpable. No hay que renunciar a ellos, sino reintroducirlos poco a poco cuando la rodilla está lista.

Entonces, ¿por dónde empiezo?

- 1 **Deja de temer al movimiento.** Correr no gasta la rodilla. La fortalece. El miedo es el que te debilita.
- 2 **No pares del todo: ajusta.** Reduce lo que dispara el dolor, mantén el resto, no te vayas al sofá.
- 3 **Construye tolerancia con fuerza.** Rodilla y cadera, cargando de verdad. Es lo que sube tu "saldo".
- 4 **Progresas despacio.** Volumen antes que intensidad. Las bajadas, las últimas.

Una última cosa

Saber esto es fácil. Lo difícil es aplicarlo bien: saber cuánta carga es la justa para tu rodilla, qué ejercicios y con qué progresión, cuándo apretar y cuándo frenar, y no abandonar a las tres semanas. Ahí es donde casi todo el mundo se cae —o se lesiona de nuevo.

Si arrastras molestias de rodilla y quieres seguir moviéndote sin miedo —construyendo una rodilla que aguante lo que le pides, a tu ritmo y con alguien que ajuste el plan contigo—, [escribeme](#), [llamada y hablamos](#) (o haz clic ahí y se abre tu correo listo). **Sin compromiso.** A veces una sola conversación te ahorra meses de parar y recaer.

Esta guía resume evidencia científica actual con fines informativos. No es consejo médico ni sustituye el diagnóstico de un profesional sanitario. Si tu dolor de rodilla viene tras un golpe fuerte, con hinchazón marcada, fiebre, bloqueo de la articulación, incapacidad de apoyar el peso, o si es intenso y no mejora, consulta con un médico o fisioterapeuta sin demora.